



FACULTAD DE OBSTETRICIA Y ENFERMERÍA
HILDA ZORAIDA BACA NEGLIA
ESCUELA DE ENFERMERIA

ADOPCIÓN DEL ROL MATERNAL DE LAS MADRES PRIMERIZAS
EN EL CUIDADO DEL LACTANTE MENOR DE 1 AÑO, EN EL
SERVICIO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CENTRO DE
SALUD MIRONES BAJO, OCTUBRE 2024

PARA OPTAR
EL TÍTULO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

PRESENTADO POR:
CARLA IVETTE CARRASCO VILLARREAL

ASESOR (A)

LIMA, PERÚ

2024

INDICE

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	3
1.1 Descripción de la situación problemática	3
1.2 Formulación del problema	¡Error! Marcador no definido.3
1.3 Objetivos de la investigación.....	8
1.4 Justificación de la investigación	11
1.4.1 Importancia de la investigación.....	11
1.4.2 Viabilidad del estudio	13
1.5 Limitaciones de estudio	14
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.....	15
2.1 Antecedentes de la investigación.....	15
2.2 Bases teóricas.....	18
2.3 Definición de términos básicos	25
CAPÍTULO III: HIPÓTESIS (si las hubiera) Y VARIABLES.....	26
3.1 Formulación de hipótesis principal y derivadas (si las hubiera).....	26
3.2. Variables y definición operacional	26
CAPITULO IV: METODOLOGIA	29
4.1 Diseño metodológico.....	29
4.2 Diseño muestral	30
4.2.1Criterios de selección	30
Criterios de inclusión:	30
4.3 Técnica de recolección de datos.....	31
4.4 Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información	32
4.5 Aspectos éticos	32
CRONOGRAMA.....	34
PRESUPUESTO	35
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	36

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción de la situación problemática

El rol materno crea un vínculo esencial de amor, protección y cuidado al recién nacido durante los primeros años de vida. Sin embargo, diversos factores pueden interferir en el cumplimiento de esta función, provocando conflictos familiares, problemas sociales y de salud tanto para la madre como para el hijo.¹

Es importante mencionar, la importancia que desempeña las madres primerizas en el cuidado del lactante menor, en su primer encuentro con él bebe. Por lo tanto, es esencial que le brinde dedicación, responsabilidad y compromiso para asegurar que el cuidado se lleve a cabo de manera oportuna, considerando el apego que se va formando hacia el niño.²

A nivel de América Latina y el Caribe, Organización Mundial de la salud (OMS)³, refiere que, en el 2022, el África subsahariana representó el 57% de todas las defunciones de menores de 5 años. Esa región registró la tasa de mortalidad neonatal más alta del mundo, seguida de Asia Central y meridional con una tasa de mortalidad neonatal de 21 defunciones por cada 1000 nacidos vivos. Las principales causas de estas muertes incluyen el parto prematuro, infecciones neonatales y las anomalías congénitas. La

meta para reducir las tasas de mortalidad, es esencial mejorar la calidad de la atención durante el embarazo y el período neonatal a través de la implementación de programas efectivos.

En Centroamérica, específicamente en Montevideo⁴, en el 2022, se estimaron 152.000 las defunciones de menores de 5 años, lo que representa un descenso de 60% desde el año 2000. En el 2024, se estimó el 57% de las muertes estimadas en menores de 5 años se concentran en los primeros 28 días de vida, mientras que a nivel mundial esta cifra es del 47%. La meta para reducir las tasas de mortalidad se centra en que el sistema priorice la prestación de atención primaria de calidad, garantizando la implementación de intervenciones esenciales y de un tratamiento oportuno.

En México⁵, en el 2024, un estudio titulado Rol en adolescentes primigestas en el primer nivel de atención, se determinó el 71% las madres protegen a sus hijos según la dimensión vínculo afectivo. Las mayorías de las madres tienen edades entre 16 y 18 años (35 %).

Mientras que, en Colombia, en el 2022, se determinó que la adopción del rol materno puede depender de muchos factores como la familia, pareja, el entorno que las rodea. Donde destacan la importancia de la adopción maternal enfocado en las mujeres puérperas y gestantes ya sean adolescentes o adultas, basándonos en la teoría de ramona merced, demostrando los aspectos que rodearon a las madres durante su proceso.⁶

Así mismo en Ecuador, en el 2020, se evidencio el contacto con el rol de la madre, sobre todo en las primerizas, puede generar empatía y familiaridad en torno a la relación que se va a generar entre la madre y el bebé, tanto las emociones como las actitudes. Por lo tanto, las madres primerizas alcanzan un rol materno, en este primer contacto, que contribuya con el desarrollo en los cuidados y el fortalecimiento en su rol materno para identificar procesos que la vinculen con asumir este nuevo rol.⁷

En el Perú⁸, en el 2023, se calcula las mujeres tuvieron alrededor de dos hijos durante su vida reproductiva. La fecundidad en adolescentes ha mostrado una disminución significativa del 24.8%. Mientras que en el año 2000 se registraban 74.2 nacimientos por cada 1000 mujeres de entre 15 y 19 años, para el 2023 esta cifra bajó a 55.8., para el 2023 descendió 56%.

Investigaciones a nivel nacional, como el estudio de ENDES⁹, 2023 sustenta que las madres primerizas tienen en promedio 1,9 hijos. De acuerdo a la residencia, en el en el área rural las mujeres tienen 2,8 hijos a comparación, en el área urbana 1,7 hijos. En ese mismo año, en el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)¹⁰, anunció que existen 8 millones 891 mil madres. De este total, el 60,1% tienen de 15 a 49 años de edad, es decir, la madre al nacimiento de su primer hijo es de 22 años.

En Perú según Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021, nos indica que la maternidad temprana conduce responsabilidades en diferentes ámbitos, en la crianza, restricciones materiales y educativas. Por ello aumenta la probabilidad de que las hijas de las madres adolescentes sigan la trayectoria social de sus progenitoras, que repitan el ciclo de procreación a temprana edad.¹¹

Ramona¹² en el 2018, se centra en la transformación que ocurre durante la maternidad. Al profundizar en su teoría, es donde la madre desarrolla un vínculo con su hijo, experimentando placer, gratificación y una sensación de armonía en este nuevo rol, lo que refuerza su identidad como madre. De este modo, el cuidado es significativo y transformador ante el gran desafío de convertirse en madre.

En el Centro de Salud Mirones Bajo, puede observar que en el servicio de CRED, las madres primerizas a la entrevista refieren “quiero aprender más del cuidado de mi hijo”, “el ser madre por primera vez se me hace muy difícil”, “cuando mi hijito llora no sé qué hacer”. Además de ello, al realizar la evaluación de enfermería, se pudo percibir que las madres no tienen afecto hacia sus hijos. En base a ello se observa que hay poca relación entre la madre y el establecimiento de salud, debido a que las madres no acuden a sus citas programadas.

Problema general

Dada la situación descrita, surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es la adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del lactante menor de 1 año, en el servicio de crecimiento y desarrollo del Centro de Salud Mirones Bajo Octubre ,2024?

1.2.2 Problemas específicos

- ¿Cuál es la adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del lactante menor de 1 año, respecto aceptación del bebe del Centro de Salud Mirones Bajo Octubre ,2024??
- ¿Cuál es la adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del lactante menor de 1 año, respecto al contacto con el rol de la madre del Centro de Salud Mirones Bajo Octubre ,2024?
- ¿Cuál es la adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del lactante menor de 1 año, respecto estimulación del bebe del Centro de Salud Mirones Bajo Octubre ,2024?
- ¿Cuál es la adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del lactante menor de 1 año, respecto expresiones maternas de afecto hacia él bebe del Centro de Salud Mirones Bajo Octubre ,2024?
- ¿Cuál es la adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del lactante menor de 1 año, respecto al bienestar al bebe del Centro de Salud Mirones Bajo Octubre ,2024?

- ¿Cuál es la adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del lactante menor de 1 año, respecto preocupación y protección del bebe del Centro de Salud Mirones Bajo Octubre ,2024?
- ¿Cuál es la adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del lactante menor de 1 año, respecto interacción con la pareja respecto al bebe del del Centro de Salud Mirones Bajo Octubre ,2024?
- ¿Cuál es la adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del lactante menor de 1 año, respecto interacción con la familia de origen respecto al bebe del Centro de Salud Mirones Bajo Octubre ,2024?
- ¿Cuál es la adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del lactante menor de 1 año, respecto al cuidados del bebe del Centro de Salud Mirones Bajo Octubre ,2024?

1.3 Objetivos de la investigación

Objetivo general

Determinar la adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del lactante menor de 1 año, en el servicio de crecimiento y desarrollo del Centro de Salud Mirones Bajo Octubre ,2024.

Objetivos específicos

- Identificar la adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del lactante menor de 1 año, respecto aceptación del bebe del Centro de Salud Mirones Bajo Octubre ,2024
- Identificar la adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del lactante menor de 1 año, respecto al contacto con el rol de la madre del Centro de Salud Mirones Bajo Octubre ,2024
- Identificar la adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del lactante menor de 1 año, respecto estimulación del bebe del Centro de Salud Mirones Bajo Octubre ,2024
- Identificar la adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del lactante menor de 1 año, respecto expresiones maternas de afecto hacia él bebe del Centro de Salud Mirones Bajo Octubre ,2024
- Identificar la adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del lactante menor de 1 año, respecto al bienestar al bebe del Centro de Salud Mirones Bajo Octubre ,2024
- Identificar la adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del lactante menor de 1 año, respecto preocupación y protección del bebe del Centro de Salud Mirones Bajo Octubre ,2024

- Identificar la adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del lactante menor de 1 año, respecto interacción con la pareja respecto al bebe del del Centro de Salud Mirones Bajo Octubre ,2024
- Identificar la adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del lactante menor de 1 año, respecto interacción con la familia de origen respecto al bebe del Centro de Salud Mirones Bajo Octubre ,2024
- Identificar la adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del lactante menor de 1 año, respecto al cuidados del bebe del Centro de Salud Mirones Bajo Octubre ,2024
- Identificar la adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del lactante menor de 1 año, respecto conocimiento y cultura relacionados al bebe del Centro de Salud Mirones Bajo Octubre ,2024

1.4 Justificación de la investigación

1.4.1 Teórica

Desde un punto de vista teórico, los resultados del estudio permitirán conocer la realidad sobre el rol que cumple las cuidadoras hacia sus menores hijos. Asimismo, literatura científica ha evidenciado que un nivel adecuado de conocimiento de las madres sobre cuidados básicos está directamente relacionado con una mejor habilidad por parte de ellas, y una mayor conciencia de su importancia. Los resultados permitirán desarrollar ideas, realizar recomendaciones, ya que al mejorar el conocimiento de las madres puede tener un impacto positivo en la salud pública y facilitar una detección temprana sobre un óptimo cuidado, este enfoque también considerará las competencias en desarrollo de las enfermeras, integrándolas en su compromiso con la organización, según lo planteado por Ramona Mercer.

El enfoque de enfermería estará respaldado teoría Ramona Mercer (1929) quien en su teoría "Adopción del rol maternal" resalta la importancia del cuidado de la madre a su menor hijo.

1.4.2 Metodológica

Considerando el aspecto metodológico, Tamayo¹³ indica que se utiliza en la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación, y en la medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadística actualizada para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. La recopilación de datos, va garantizar que los resultados sean relevantes en ese contexto específico y refleje la situación actual. Para lograr ello, se llevará a cabo una recopilación de datos, con el propósito de identificar y cuantificar la de adopción de las madres, lo que permitirá obtener resultados precisos y comparables que contribuirán a la toma de decisiones informadas, a la mejora de atención en este entorno del primer nivel de atención.

1.4.3 Practica

En este aspecto, Mercer¹⁴ nos indica que el estudio sobre el desarrollo del concepto de identidad materna, contribuirán al desarrollo de la buena práctica profesional. Asimismo, se desarrollarán en un contexto de alta complejidad, por los ambientes donde ocurre la acción de enfermería, por la relación establecida entre cuidadores y usuarios, y por las características de esas mismas intervenciones. Además, este estudio nos permitirá conocer los hallazgos servirán como base para fortalecer, cambiar o crear políticas y estrategias para mejorar la adopción del rol maternal

1.4.2 Viabilidad del estudio

Para la realización de esta investigación en el futuro, el acceso a la información será de suma importancia. Esto facilitará la recolección de datos directamente de las madres en el Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Centro de Salud Mirones Bajo, asegurando la relevancia y calidad de la información obtenida.

La recolección de datos se realizará a través de cuestionarios, una metodología eficiente que permitirá obtener resultados en un plazo de tiempo adecuado. Esto hace que el estudio sea viable en términos de recursos y tiempo. Es importante mencionar que se emplearán fuentes como revistas, libros y tesis para proporcionar una base teórica sólida a la investigación.

Por todo lo mencionado, la viabilidad de esta investigación se basará en el acceso a los datos del Centro de Salud, la metodología de recolección de datos, el financiamiento disponible será autofinanciado por mi persona y la utilización de fuentes escritas. Estos elementos combinados hacen que la investigación sea factible y posea un gran potencial para generar resultados significativos en relación.

1.5 Limitaciones de estudio

En esta investigación se obtendrá información solo del Centro de Salud Mirones Bajo, en primera instancia estos datos solo servirán para Diris Lima Centro, sin embargo, al ser publicado esta información se podrá extrapolar a otros establecimientos de salud.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación

Marín ¹⁵, en 2024, publicó una investigación sobre “Rol Materno en Adolescentes Primigestas en el Primer Nivel de Atención”. Su metodología fue de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo no experimental y de corte transversal. Se aplicó como técnica la entrevista y como instrumento el cuestionario. Con un alfa de Cronbach de 0,87 y validado 3 juicios de expertos, la muestra estuvo conformada por 100 adolescentes primigestas que acuden a controles prenatales en un establecimiento de salud público. Sus resultados fueron que el rol materno en adolescentes primigestas, subraya la necesidad de un enfoque multidisciplinario y comprensivo en la atención de salud.

Mantilla E et al ¹⁶, en 2024 publicó una investigación sobre Adopción del rol materno frente al cuidado del recién nacido en madres adolescentes primerizas en el Centro de Salud la Perla-Callao, 2023. Su metodología fue enfoque cuantitativo, tipo descriptivo no experimental y de corte transversal. Sus resultados fueron en la dimensión microsistema, se evidencia hay 80% de madres primerizas, con un nivel medianamente favorable en la estimulación temprana.

Herrera E ¹⁷, en 2021, publicó una investigación sobre Adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del lactante menor de 1 año de un Centro Materno Infantil de Comas, 2020. Su metodología fue enfoque cuantitativo, tipo descriptivo no experimental y de corte transversal. Sus resultados fueron el rol en la dimensión microsistema, con un nivel medianamente favorable en la aceptación del bebe.

Gamarra L et al ¹⁸, en 2021, publicó una investigación sobre Adopción del rol materno en madres adolescentes primerizas. Monsefú. Su metodología fue enfoque cuantitativo, tipo descriptivo no experimental y de corte transversal. Sus resultados fueron la adopción del rol materno en el grupo de adolescentes participantes del estudio, el que va desde la negación y el miedo, hasta la confrontación con una realidad concreta en el primer encuentro con su bebé, lo que lleva a asumir con responsabilidad su rol y afrontar sus limitaciones para lo que el apoyo familiar y social resulta muy importante.

2.2 Bases teóricas

2.2.1. Base teórica de la variable adopción maternal

a. Definiciones

Rubín 2011 refiere¹⁹ el concepto del rol materno es un como un complejo proceso cognitivo y social que es aprendido recíproca e interactivamente y cuyo fin es la unión madre - hijo y la identificación de ésta con el rol maternal, de modo que logre verse en éste y sentirse cómoda con él. Por su parte Mercer, 2004 revelo que la maternidad, es la adopción del rol materno como un proceso interactivo y evolutivo, en el cual la madre se va sintiendo vinculada a su hijo, adquiere competencias en la realización de los cuidados asociados a su papel y experimenta placer y gratificación dentro del mismo.²⁰ Por su parte, Kimelman, 2003 señalo que el instinto maternal no es inherente a la condición de la mujer y por lo tanto, el instinto maternal no existe como tal, pues a pesar de estar determinado por la presencia de un gen, necesita de ciertas experiencias sociales relacionadas con la maternidad²¹

Fernández 2021, define ²² que la madre primeriza se enfrenta a grandes cambios en su nuevo rol, en torno a tres categorías: los cambios en el estilo de vida, los sentimientos y las percepciones. Además, determinaron como estresantes en su nueva función: los cambios en la relación de pareja, los sentimientos encontrados y la falta de apoyo. Por su parte Nardone et al 2011, afirma que las madres primerizas, tanto antes del embarazo como después del parto, están integradas en un sistema familiar con normas y formas de interacción establecidas por sus miembros. Sin embargo, dependiendo de las interacciones que se produzcan entre ellos, pueden generarse vínculos saludables o patológicos que podrían predisponer a los miembros de la familia a desarrollar problemas de comportamiento en las diferentes etapas del desarrollo humano.²³

2.2.2 Dimensiones de la variable adopción del rol maternal

a. Aceptación del bebe

Como primera dimensión, Iglesias 2021, indica que la conceptualización de esta dimensión identifica la aceptación requiere que la familia se involucre activamente en apoyar al individuo, facilitando su aprendizaje y el desarrollo de una autoestima fuerte y sólida. Es fundamental aprender a vivir con las diferencias y encontrar la felicidad en este proceso, demostrando que la aceptación y la felicidad están intrínsecamente relacionadas.²⁴

b. Contacto con el rol de madre

Conceptualizando esta dimensión Iglesias, 2023 refiere que el contacto con el rol de la madre desempeña un papel crucial como guía en la vida de sus hijos, fomentando su independencia y transmitiéndoles amor y respeto, junto con otros valores esenciales. Estos aspectos fundamentales en la crianza no están condicionados por el nivel socioeconómico de la madre o por su nivel de formación profesional.²⁵

c. Expresiones maternas de afecto hacia el bebé

Esta dimensión descrita por, Casas 2022, indica que las expresiones maternas juegan un papel crucial en el comportamiento humano en todas las etapas de la vida, ejerciendo una influencia significativa. Desde el primer encuentro con su bebé, la mujer experimenta un vínculo afectivo que le proporciona sensaciones de placer y vitalidad.²⁶

d. Bienestar del bebé

Según la Organización Mundial de la Salud en el año 2024, tiene como objetivo concientizar sobre la importancia del cuidado de los recién nacidos. Además, proporciona información basada en evidencia para la atención adecuada del recién nacido. Estos esfuerzos buscan asegurar cuidados de calidad, contribuir a la reducción de la tasa de mortalidad neonatal y sensibilizar sobre la necesidad de actuar frente a situaciones que requieran intervenciones específicas.²⁷

e. Preocupación y protección del bebé

Según la escuela de salud de Rebagliati, 2023 nos indica que los bebés son particularmente vulnerables a las enfermedades comunes debido a su sistema inmunológico en desarrollo. Afortunadamente, hay medidas preventivas y tratamientos efectivos que pueden ayudar a mantener a los bebés saludables y felices. Para proteger su salud, es esencial adoptar buenas prácticas de higiene, fomentar la lactancia materna, administrar las vacunas recomendadas y evitar el contacto con personas enfermas. Estas acciones pueden reducir significativamente el riesgo de que tu bebé contraiga enfermedades comunes.²⁸

f. Interacción con la pareja respecto al bebé

Esta dimensión, descrita por, Marín et al 2023, indica que los padres tienen una carga emocional puede ser intensa y repentina, ya que suelen experimentar de manera más abrupta la transición de su modo de vida anterior. El papel del padre durante el embarazo varía en cada etapa de la gestación; en algunos momentos es principalmente emocional, mientras que en otros requiere una participación más activa. En cualquier caso, la comunicación continua entre ambos miembros de la pareja es crucial a lo largo del embarazo.²⁹

g. Interacción con la familia de origen respecto al bebé

En esta dimensión, Fass et al, 2023 nos menciona que la práctica de una comunicación activa en el entorno familiar es crucial, ya que tanto el emisor como el receptor desempeñan papeles importantes, creando un diálogo e interacción dinámicos. Las relaciones familiares tienen un impacto significativo en el desarrollo físico y emocional del individuo, dado que la familia es una de las principales instituciones de la sociedad. Los estudios indican que la familia actúa como un factor protector durante la primera infancia, facilitando la formación de valores y el establecimiento de normas. La calidad del vínculo familiar influye en las oportunidades para construir experiencias personales.³⁰

h. Cuidados del bebe

Esta dimensión, descrita por, Anzilotti et al 2018, indica Cuidar de un recién nacido también implica cuidar de uno mismo. Considere buscar ayuda durante esta etapa, que a menudo puede sentirse caótica y llena de nuevas demandas. Mantener a su bebé saludable es crucial, por lo que cualquier persona que cuide o esté en contacto con su pequeño debe estar al día con sus vacunas y sentirse bien. Si no desea recibir visitas o tiene otras preocupaciones, no se sienta culpable por limitar el número de visitas.³¹

i. Conocimiento y cultura relacionados al bebé

Esta dimensión, descrita por, Zulca et al 2024, señala que los conocimientos y habilidades que tanto el niño como la familia aportan a la comunidad de aprendizaje comprender las prácticas y experiencias culturales de las familias, o "fondos de conocimiento", es fundamental para ofrecer entornos y experiencias educativas que reflejen y respeten las diversas culturas.³²

j. Apoyo profesional durante la adopción del rol materno

Conceptualizando esta dimensión Alvarado et al, 2023 señala que todo puede obstaculizar que la madre asuma correctamente su rol. Por esta razón, Ramona Mercer resalta la importancia del apoyo de los profesionales de enfermería en este proceso. En su teoría, Mercer enfatiza la necesidad de tener en cuenta la influencia del entorno familiar, la escuela, el trabajo, la iglesia y otras entidades comunitarias en la adopción del rol materno.³³

2.3 Definición de términos básicos

Apego: Se produce cuando los cuidadores principales actúan de manera sensible, cálida, acogedora y atentos a las necesidades del niño.³⁴

Afectividad: Es el desarrollo emocional inicia cuando el niño establece sus primeras conexiones a través del llanto para comunicarse y espera que sus necesidades sean atendidas.³⁵

Expectativas de crianza: Es la visión de una idea general del cómo se criarán los niños cuando el rol de madre no puede asimilare por completo.³⁶

Estimulación: Es ofrecer un ambiente y un sostén adecuados para cada edad, teniendo en cuenta las necesidades de cada etapa.³⁷

Maternidad: Es un fenómeno sociocultural complejo que va más allá de los aspectos biológicos de la gestación y el parto.³⁸

Respeto: Es un valor, que permite al ser humano reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos.³⁹

Salud: Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.⁴⁰

CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES

3.1 Formulación de hipótesis principal y derivadas (si las hubiera)

El presente estudio no aplica hipótesis ya que es de nivel descriptivo. No aplica

3.2. Variables y definición operacional

3.2.1 Variables

Adopción del rol materno en las madres primerizas

3.2.2 Definición conceptual

Según Ramona Mercer⁴¹ la adopción del rol maternal se basa en desarrollar competencias esenciales para proporcionar cuidados que mejoren la experiencia. A medida que la madre se siente más conectada con su hijo y adquiere habilidades en los cuidados propios de su rol, alcanza la culminación de este proceso: la identidad materna.

3.2.3 Definición operacional: Se evaluará mediante un cuestionario que determinará competencias medidas con los estándares de alto, medio y bajo. Este fue elaborado por el autor Garrido y Marchan, 2011, Perú, lleva por título “Escala de Adopción del Rol Materno”⁴²

Variable	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición
Adopción del rol maternal en las madres primerizas.	Se evaluará mediante un cuestionario que determinará competencias medidas con los estándares de alto, medio y bajo. Este fue elaborado por el autor Garrido y Marchan, 2011, Perú, lleva por título “Escala de Adopción del Rol Materno” ⁴²	Aceptación del bebe	Aceptación, vínculo, apego.	Puntaje • 203 – 224 (Nivel Alto) • 181 – 202 (Nivel Medio) • 56 – 180 (Nivel Bajo)
		Contacto con el rol de madre.	Percepción y adopción del rol maternal.	
		Estimulación del bebe	Estimulación social, coordinación motora y lenguaje.	
		Expresiones maternas de afecto hacia él bebe.	Afectividad.	
		Bienestar del bebe	Cuidado, alimentación, seguridad.	
		Preocupación y protección del bebe.	Protección del bebé.	
		Interacción con la pareja respecto al bebe.	Cuidados del padre.	
		Interacción con la familia de origen respecto al bebe.	Compartir cuidados, compartir responsabilidades, aceptación.	
		Cuidados del bebe.	Salud, alimentación, protección	
		Conocimiento y cultura relacionados al bebe.	Conocimiento sobre el cuidado, estimulación, respeto.	

CAPITULO IV: METODOLOGIA

4.1 Diseño metodológico

El enfoque establecido para esta investigación es el cuantitativo definido según Aguirrezabala et al⁴³, como el paradigma se centra en la cuantificación de variables y la contrastación empírica de los hechos para hallar conocimiento positivo(verificable). En este estudio, la variable: adopción del rol materno, es medida a troves de técnicas y procedimientos sistematizados, a para operar una serie de análisis estadísticos sobre los niveles obtenidos (numéricos). Por lo tanto, el diseño es no experimental según Hernández et a⁴⁴ quienes refieren que se trata del plan de investigación que no contempla modificación de variables ni grupos aleteo rizados, tampoco la aplicación de ningún tipo de intervención en el contexto del estudio. En este caso el interés es determinar los niveles la adopción del rol materno en madres primerizas de lactantes menor de 1 año, que se atienden a sus niños en el Centro de Salud Mirones Bajo, ubicado en el distrito de Cercado de Lima.

4.2 Diseño muestral

La población total estará conformada por 60 madres primerizas de niños menores de 1 año que acudirán al servicio de crecimiento y desarrollo de CRED, del Centro de Salud Mirones Bajo, 2024

Por lo tanto, se trabajará con las 60 madres a través de la población censal.

4.2.1 Criterios de selección

Criterios de inclusión:

- Madres de niños mayores de 15 años.
- Madres de niños que firman el consentimiento informado

Criterios de exclusión

- Madres de niños que no presente H.C
- Madres de niños con trastornos mentales.

4.3 Técnica de recolección de datos

La técnica que se aplicará será la encuesta y como instrumento el cuestionario titulado "Escala de Adopción del Rol Materno", este cuestionario, fue modificado y elaborado Garrido y Marchan Lima, Perú en el año 2011⁴², cuenta con 56 preguntas, clasificadas por 10 dimensiones. Este instrumento está estructurado por datos generales como edad de la madre, estado civil, grado de instrucción, edad del niño, sexo del bebe y datos específicos de tipo Likert de las 10 dimensiones : Aceptación del bebe, contacto con el rol de madre, estimulación del bebe, expresiones maternas de afecto hacia él bebe, bienestar del bebe, preocupación y protección al bebe, interacción con la familia de origen respecto al bebe, interacción con la familia de origen respecto al bebe, cuidados del bebe, conocimiento y cultura relacionados al bebe.

La validación se llevó a cabo mediante 10 juicio de expertos. Además, se evaluó la confiabilidad usando el coeficiente Alfa de Cronbach con un valor de $\alpha=0,94$ ($\alpha >0,7$), lo que demuestra una confiabilidad muy alta.

4.4 Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información

El procesamiento de la información se realizará en una base de datos, en el programa estadístico SPSS24, donde serán ordenados y tabulados en el programa de Excel, lo cual será representada por tablas académicas, aplicando la estadística descriptiva, como las medidas tendencia central, frecuencias y porcentajes.

4.5 Aspectos éticos

Esta investigación será aceptada por el Comité de Ética de la Universidad San Martín de Porres. La investigación será aprobada la Diris Lima Centro, y autorizada para la recolección de datos en dicho establecimiento.

Tiene en cuenta los principios éticos

Autonomía: Se respetará la libre disposición de participar en las encuestas mediante el llenado del consentimiento informado a las madres primerizas, se respetó las respuestas que esta coloque sin verse presionada o influenciada por otras personas, serán libres de retirarse en cualquier momento si no desean participar en el trabajo de investigación.

Principio de Beneficencia: Mediante los resultados de este trabajo de investigación se tomarán y optaron medidas para aumentar la adopción de las madres primerizas que se atienden en el puesto de salud y así con ayuda de ellas poder evitar cuidados de los lactantes menores.

No maleficencia: Este trabajo de investigación no habra ningún daño físico ni psicológico a la madre del menor de 1 año, al contrario, identificamos la adopción del rol maternal y así ella pueda adoptar medidas beneficiosas para el menor contribuyendo para un mejor futuro de este.

Justicia: La técnica se aplicará a todas las madres de lactante menores de 1 año; a todos los participantes se les tratara de forma justa sin distinción de raza, costumbres, etc., además los resultados serán entregados a las autoridades del puesto salud con el fin de que las madres que participaron en el trabajo de investigación.

CRONOGRAMA

N°	Actividades	Meses 2024					
		Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Identificación y del formulación problema	X					
2	Revisión de las fuentes de información		X				
3	Redacción de objetivos y operacionalización de las variables			X			
4	Determinación del diseño de investigación				X		
5	Determinación del marco muestral				X		
6	Selección de los estadígrafos a utilizar				X		
7	Recolección de datos				X	X	
8	Organización y de procesamiento los datos						X
9	Análisis e de interpretación los resultados						X
10	Redacción del informe						X
11	Presentación del informe						X

PRESUPUESTO

Tipo	Servicios	Unidad	Costo unidad	Monto total
Recursos humanos	Investigador	1	350	350
	Personal para la tabulación	1	250	250
	Sub total			600
Adquisición de bienes	Copias	50	0.20	10
	Internet	20	2.0	40
	lapicero	4	1.00	4
	Sub total			54
	Refrigerio	5	2.50	12.50
	Movilidad	7	1.00	7
	Sub total			19.50
Total general				673.50

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Guzmán A. Salud de la mujer Rol materno. [pdf].Cuzco: Universidad Nacional San Antonio Abad del Cuzco; 2024 [citado 15 de agosto 2024].9 p disponible de: <https://www.studocu.com/pe/document/universidad-nacional-de-san-antonio-abad-del-cusco/enfermeria-en-salud-de-la-mujer/salud-de-la-mujer-rol-materno/96966910>
2. Salas C. Martín M. Bárcenas I. Canorea C. Chiclana C. Serrano E. Evaluación de las preocupaciones de padres primerizos en el período perinatal. estudio piloto. VI Jornada de salud mental perinatal, Barcelona: [PDF]. Barcelona;2017. [citado 15 de agosto 2024]..1 p. Disponible de:<https://raco.cat/index.php/PsicosomPsiquiatr/article/view/393690>
3. Organización mundial de la salud. [internet]. OPS; c2024. Mortalidad Materna [citado 15 de agosto 2024]; [1 pantalla]. Disponible de: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/newborn-mortality>

4. Organización panamericana de la salud. [internet]. OPS; c2024. Tendencias alentadoras y desafíos persistentes: Análisis de mortalidad en menores de 5 años y perspectivas en América Latina y el Caribe [citado 15 de agosto 2024]; [1 pantalla]. Disponible de: <https://www.paho.org/es/noticias/14-5-2024-tendencias-alentadoras-desafios-persistentes-analisis-mortalidad-menores-5-anos>
5. Marin A, Cartuche D, Paccha C. Rol materno en adolescentes primigestas en el primer nivel de atención. [Revista]. Ecuador: Universidad Técnica de Machala;2024. [citado 15 de agosto 2024].17 p. Disponible de:<https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/10296/15118>
6. Cadena B. Durand J. Mendoza L. Adaptación de rol materno en madres adolescentes y adultas a partir de la teoría de ramona merced. [Tesis de licenciatura]. Colombia: Universidad Cooperativa de Colombia;2022. [citado 15 de agosto 2024].54 p. Disponible de: <https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/ac729864-e6e4-45ed-8dc0-fd377e0b2420/content>
7. Verdesoto G. Zambrano M. Adopción del rol materno en primíparas según Ramona Mercer [Tesis de licenciatura]. Ecuador: Universidad Nacional de Chimborazo Facultad de Ciencias de la Salud Enfermería; 2020 [citado 15

de agosto 2024]. Disponible de:

<http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/6750/1/TESIS%20Gabriela%20Alexandra%20Verdesoto%20Y%20Maryorie%20Zambrano%20ENF..pdf>

8. Organización panamericana de la salud. [internet]. Perú. OPS; 2023. La situación de salud - materno Infantil [citado 15 de agosto 2024]; [1 pantalla]. Disponible de: <https://hia.paho.org/es/paises-2022/perfil-peru>
9. Encuesta demográfica y de salud familiar [Internet]. Lima: ENDES; c2023. Madre tienen en promedio 1,9 hijos en el 2023 ;11 de mayo 2024 [citado 15 de agosto 2024].Disponible de: <https://www.gob.pe/institucion/inei/noticias/952773-este-domingo-cerca-de-9-millones-de-madres-conmemoran-su-dia-en-el-peru>
10. Instituto Nacional de Estadística e Informática [Internet]. Lima: INEI; c2023. 9 millones de madres conmemoran su día en el Perú en el 2023. [citado 15 de agosto 2024].Disponible de: <https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/mas->
11. Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables. [internet]. Lima: MINSA; c2012 - 2021. Plan nacional de acción por la infancia y la adolescencia [citado 15 de agosto 2024]. 129 p. Disponible

de:https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pdf/Documento_PNAIA.pdf
f

- 12.** Santos M. Pérez M. Lozada E. Ramírez N. Landeros E. Validez y confiabilidad de la Escala de Adopción al Rol Materno en madres adolescentes mexicanas. Vol. 18. México: Artículo; 2021. 3 p. [citado 15 de agosto 2024]. Disponible de:https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-70632021000100069
- 13.** Tamo A. Metodología; 2007. 1p cuantitativa [citado 15 de agosto 2024]. Disponible de:https://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/eal/metodologia_cuantitativa.html
- 14.** Meleis AI. Theoretical Nursing: Development and Progress. 5th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/ Lippincott Williams & Wilkins; 2012.
- 15.** Marin A, Cartuche D, Paccha C. Rol materno en adolescentes primigestas en el primer nivel de atención. [Revista]. Ecuador: Universidad Técnica de Machala; 2024. [citado 15 de agosto 2024]. 17 p. Disponible de:<https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/10296/15118>
- 16.** Mantilla E. Jaime J. Castro R. Adopción del rol materno frente al cuidado del recién nacido en madres adolescentes primerizas en el Centro de Salud la Perla-callao, 2023. [Tesis de licenciatura]. Perú: Universidad Nacional del Callao; 2024. [citado 15 de agosto 2024]. 94 p. Disponible de:<https://repositorio.unac.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12952/8907/T>

[ESIS%20-%20MANTILLA-JAIMES-CASTRO.pdf?sequence=1&isAllowed=y](#)

- 17.** Herrera L. Adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del lactante menor de 1 año de un centro materno infantil de comas, 2020. [Tesis de especialidad]. Perú: Universidad Privada Norbert Wiener;2021. [citado 15 de agosto 2024].55 p. Disponible de: https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/5399/T061_10747056_S.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- 18.** Gamarra Adopción del rol materno en madres adolescentes primerizas. Monsefú, 2019. [Tesis de especialidad]. Perú: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo ;2021. [citado 15 de agosto 2024].51 p. Disponible de:<https://repositorio.unprg.edu.pe/handle/20.500.12893/10431>
- 19.** Rubín. Adopción del rol materno en madres adolescentes primerizas según, grupo de convivencia. Perú: Universidad Cesar Vallejo;2011. [citado 15 de agosto 2024].28 p. Disponible de:<https://revistas.ucv.edu.pe/index.php/revpsi/article/download/664/638/652>
- 20.** Mercer R.Becoming a Mother Versus Maternal Role Attainment. Journal of nursing scholarship. [Revista]. 2021 [citado 28 de Agosto 2024].20 p. Disponible de:https://www.researchgate.net/publication/8222569_Becoming_a_Mother_Versus_Maternal_Role_Attainment
-

-
21. Kimelman et al. Adopción del rol materno en madres adolescentes primerizas. [Revista]. 2021 [citado 28 de Agosto 2024]. 18 p. Disponible de: [file:///C:/Users/KARLA/Downloads/a02v13n1%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/KARLA/Downloads/a02v13n1%20(4).pdf)
22. Fernández S et al. Percepción de la transición a la maternidad: estudio fenomenológico en la provincia de Barcelona. [Pdf] 2021. [citado 28 de Agosto 2024] 20 p. Disponible de: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656713001315>
23. Nardonde SA. Giannotti ME y Rocchi TA et al. Adopción del rol materno en madres adolescentes primerizas según, grupo de convivencia. Perú: Universidad Cesar Vallejo; 2011. [citado 28 de Agosto 2024]. 28 p. Disponible de: <https://revistas.ucv.edu.pe/index.php/revpsi/article/download/664/638/652>
24. Iglesias A. La aceptación en los niños. Tándem [internet]. 2021 [citado 28 de Agosto 2024]; 2 p. Disponible de: <https://www.colectivotandem.com/la-aceptacion-en-los-ninos/>
25. Iglesias A. El papel fundamental de las madres en el desarrollo de las familias. Ethany [internet]. 2023. [citado 28 de Agosto 2024]; 1 p. Disponible de: <https://colombia.bethany.org/es/recursos/el-papel-fundamental-de-las-madres-en-el-desarrollo-de-las-familias>
-

- 26.** Casas J. El papel fundamental de las madres en el desarrollo de las familias. San Cristóbal [internet]. 2022 [citado 28 de Agosto 2024]; 1 p. Disponible de: <https://www.sancristobalsl.com/blog/como-influyen-las-emociones-en-tu-embarazo/#:~:text=Hay%20estudios%20que%20demuestran%20que,est a%20etapa%20y%20disfrutarla%20plenamente>
- 27.** Organización mundial de la salud [Internet]. Lima: OMS; c2024. Campaña de los 28 días – Salud del Recién nacido ;21 de abril 2024.[citado 28 de Agosto 2024]. Disponible de: <https://www.paho.org/es/campanas/campana-28-dias-salud-recien-nacido>
- 28.** Cuidado y prevención: Como proteger a tu bebe de las enfermedades comunes; [internet]. 2023 [citado 28 de Agosto 2024]; 2 p. Disponible de: <https://rebagliatisalud.edu.pe/cuidado-y-prevencion-como-proteger-a-tu-bebe-de-las-enfermedades-comunes/>
- 29.** Marin Iral MP, Quintero Córdova PA, Rivera Gómez SC. Influencia de las relaciones familiares en la primera infancia. [internet]. 2023[citado 28 de Agosto 2024]; 1 p. Disponible de:

<https://revistas.ucatolicaluisamigo.edu.co/index.php/poesis/article/view/3196/2457>

- 30.** Fass M et al. Interacciones vinculares mama bebe: impacto de la creencia de las madres [internet]. 2023 [citado 28 de Agosto 2024]; 1 p. Disponible de: <https://www.redalyc.org/journal/773/77372885013/html/>
- 31.** Anzilotti AW. Guía para padres primerizos. Neumor Kid health. [internet]. 2018 [citado 28 de Agosto 2024]; 1 p. Disponible de: <https://kidshealth.org/es/parents/guide-parents.html>
- 32.** Zulca MT. Tener conocimientos específicos sobre la cultura del niño y la familia es esencial. Head start. [internet]. 2024 [citado 28 de Agosto 2024]; 1 p. Disponible de: <https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/culture-language/multicultural-principles-early-childhood-leaders/tener-conocimientos-especificos-sobre-la-cultura-del-nino-y-la-familia-es-esencial>
- 33.** Alvarado L. Guarín. Cañón W. Adopción del rol maternal de la teórica Ramona Mercer al cuidado de enfermería binomio madre-hijo. [Revista]. 2019. [citado 28 de Agosto 2024]. 3 p. Disponible de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2216-09732011000100015
- 34.** Cassinello M. Apego seguro ¿Qué es y cómo desarrollarlo? [Revista]. 7 de setiembre 2023. [citado 29 de Agosto 2024]. 2 p. Disponible de: <https://manuelcassinello.com/blog/apego-seguro-que-es-como-desarrollarlo/>

35. Desarrollo afectivo. Macmillan [Pdf] 2018 .[citado 29 de Agosto 2024].30 p.

Disponible de: https://www.macmillaneducation.es/wp-content/uploads/2018/10/desarrollo_socioafectivo_libroalumno_unidad1_muestra.pdf

36. Santillán L. Ciencia UNAM. Metas y expectativas en la crianza de hijos

[Revista] ;6 de enero 2020 [citado 29 de Agosto 2024].Disponible de: <https://ciencia.unam.mx/leer/942/ser-padre-o-madre-metas-y-expectativas-de-la-crianza-de-los-hijos>

37. Ferreras E. Pérez Victoria Reparto de responsabilidades y tareas en el entorno familiar. Macmillan [Pdf]. 2014 .[citado 29 de Agosto 2024].23 p.

Disponible de: <https://veredathemis.org.mx/publicaciones/RESPONSABILIDADES%2015ene.pdf>

38. Cáceres F. Molina G. Ruiz M. Maternidad: un proceso con distintos matices y construcción de vínculos. 2019. [citado 29 de Agosto 2024].11 p.

Disponible de: <http://www.scielo.org.co/pdf/aqui/v14n3/v14n3a04.pdf>

39. Estimulación temprana. Austral [Pdf]. 2024.[citado 29 de Agosto de 2024].1

p. Disponible de: <https://www.hospitalaustral.edu.ar/info-padres/que-es-la-estimulacion/>

- 40.** Organización Mundial de la Salud. [internet]. OMS; 2024. La oms mantiene su firme compromiso con los principios establecidos con los preámbulos de la constitución. [citado 29 de Agosto 2024]; [1 pantalla]. Disponible de: <https://www.who.int/es/about/governance/constitution#:~:text=La%20salud%20es%20un%20estado,o%20condici%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20o%20social>.
- 41.** Colección " personal y laboral" Desarrollo [Pdf]. 2024.[citado 29 de Julio 2024].16 p. Disponible de: <https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/29e3a524-2b61-4228-afea-ea858bc4ee87/33.pdf?MOD=AJPERES#:~:text=El%20respeto%20es%20un%20valor,individuos%20y%20de%20la%20sociedad>.
- 42.** Alvarado L. Guarín. Cañón W. Adopción del rol maternal de la teórica Ramona Mercer al cuidado de enfermería binomio madre-hijo. [Revista]. 2019 .[citado 1 de setiembre 2024].3 p. Disponible de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2216-09732011000100015
- 43.** Hernández R. Mendoza C. Metodología de la investigación. 2018. México [Pdf]. 2018 [citado 1 de setiembre de 2024].753 p. Disponible de: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://virtual.cuautitlan.unam.mx/rudics/wp-content/uploads/2019/02/RUDICSv9n18p92_95.pdf

44. Feria H. Blanco M. Valledor R. La dimensión metodológica del diseño de la investigación científica. Cuba [Pdf]. 2019 [citado 1 de setiembre de 2024].111 p. Disponible de: https://isbn.cloud/9789597225393/la-dimension-metodologica-del-diseno-de-la-investigacion-cientifica/#google_vignette

ANEXOS

ANEXO A: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

ANEXO 1: INSTRUMENTO

Cuestionario de Rol Maternal A Madres Primerizas

I. PRESENTACIÓN:

Buenos días, soy egresada de la Universidad San Martín de Porres carrera, estoy realizando un estudio, cuyo objetivo es determinar el rol maternal en madres primerizas en el cuidado del lactante menor. Pedimos su colaboración para que nos facilite ciertos datos que nos permitirán llegar al objetivo de estudio ya mencionado.

II. INSTRUCCIONES GENERALES

Estimada madre su participación en esta encuesta es fundamental para evaluar adopción rol maternal en madres primerizas. Por favor responda con total sinceridad, las siguientes preguntas. Su aporte contribuirá a mejorar la atención del cuidado del lactante menor.

Edad:

Menor de 18 años () 18 a 25 años () 26 a 35 años () 36 a 45 ()

Estado Civil:

Soltera () Casada () Conviviente () Divorciada () Viuda ()

Grado de instrucción:

Sin instrucción () Primaria () Secundaria () Técnico () universitario ()

Datos del bebé:

Edad del bebé:

Rn () 1 a 3m () 4 a 8 m () 9 a 11 m ()

Sexo del bebé:

Masculino () Femenino ()

A continuación, encontrará una lista de afirmaciones respecto a su experiencia como madre. Deberá elegir, marcando con un aspa (X), la opción que más se asemeje a su forma de pensar, actuar y sentir. No hay respuestas buenas ni malas. Las opciones de respuesta son las siguientes:

TA = Totalmente de Acuerdo.

O= Desacuerdo. A= De acuerdo.

TD=Totalmente en desacuerdo

N°	PREGUNTAS	T.A	A	D	TD
1	Prefiero no dar de lactar a mi niño, para cuidar la estética de mis senos				
2	Imito los balbuceos y sonido que hace mi hijo.				
3	Estoy dispuesta a cambiarle el pañal a mi niño cada vez que éste lo necesite.				
4	Leo información referente a los cuidados y temas relacionados a mi niño				
5	Me cuesta aceptar a este niño				
6	Cuando mi niño llora dejo lo que estoy haciendo y voy a atenderlo.				
7	Pienso que la lactancia deberá ser sustituida por la alimentación en biberón				
8	Me cuesta decir soy madre.				

9	Me siento capaz de salir adelante con mi niño.				
10	Mi familia está contenta con el nacimiento de mi niño.				
11	Le doy objetos a mi niño para que los pueda tocar y aprenda a manipularlos.				
12	Mi pareja y yo siempre estamos poniéndonos al tanto de las cosas que le pasan al niño.				
13	Cuando mi niño llora, le hablo con voz muy baja y susurrando palabras tranquilizadoras.				
14	Prefiero ser yo quien se encargue del baño de mi niño.				
15	Cuando estaba gestando pensaba con entusiasmo en el momento en que tendría a mi niño en brazos dándole d lactar				

16	Pienso que el "control de niño sano" no es necesario para mi niño				
17	El personal de salud me ha enseñado cuidados que debo tener con mi niño				
18	Cuando le hablo a mi niño le hablo con palabras cariñosas.				
19	Cuando juego con mi hijo me gusta que él aprenda algo nuevo.				
20	Cuando doy de lactar a mi niño me gusta hablarle.				
21	Me gusta mirar detenidamente a mi niño intentándolo conocerlo				
22	Me hubiera gustado que mi niño sea del sexo opuesto al que nació.				
23	El momento de juego con mi niño es indispensable en mi rutina diaria.				

24	La salud de mi niño para mí es muy importante.				
25	Para mi dar de lactar es más una obligación que una actividad agradable				
26	Cuando mi niño responde a mis cuidados, caricias u órdenes, yo lo abrazo o felicito.				
27	Me agrada masajear la espalda de mi niño con mucha delicadeza.				
28	Mi pareja me hace recordar cuando nuestro niño debe recibir sus vacunas y asistir al control de niño sano.				
29	Prefiere que alguien de mi familia se encargue de alimentar a mi niño.				
30	Mientras doy de lactar a mi niño me gusta acariciarlo.				
31	Cuando cosquilleo a mi niño observo una respuesta de alegría en él.				

32	Cuando voy a un lugar público hago valer mis beneficios por ser madre y estar con mi hijo en brazo.				
33	Aunque tenga muchas actividades que realizar, siempre me doy tiempo para cuidar de mi niño.				
34	Constantemente me informo por programas de televisión de cómo cuidar a mi hijo.				
35	Hago vacunar mi niño en la fecha programada.				
36	Sé que cuento con el apoyo de mi familia para el cuidado de mi niño.				
37	Prefiero que mi hijo tome biberón a darle de lactar.				
38	Trato que mi niño acaricie mi rostro.				
39	Tengo la seguridad que seré una buena madre.				

40	Mi pareja y yo compartimos el cuidado del niño.				
41	Cuido que mi niño utilice ropa adecuada a la estación para evitar que se enferme.				
42	Creo que dar de lactar une emocionalmente a las madres con sus hijos				
43	Me alegra mucho que mi hijo haya nacido sano.				
44	Cada vez que mi niño llora me preocupo por saber qué es lo que necesita.				
45	La forma en que crío a mi niño es muy parecida a cómo me criaron a mí.				
46	Mi familia me aconseja sobre la crianza de mi niño.				
47	Me preocupo porque a su alrededor no existan objetos que puedan hacerle daño a mi niño				

48	Trato de ocultar el hecho de que tengo un niño porque me da vergüenza.				
49	Creo que otro familiar cuida a mi niño mejor que yo				
50	Terceras personas se encargan de la crianza de mi niño.				
51	Si voy por la calle y alguien estornuda cerca, lo primero que hago es cubrir a mi niño				
52	Mi pareja es capaz de hacerse cargo de nuestro niño cuando yo no lo puedo hacer.				
53	Practico con mi niño ejercicios que le puedan ayudar a su desarrollo.				
54	Diariamente mi pareja busca saber cómo está el niño y coordinamos acerca de cómo satisfacer sus necesidades.				
55	Las cosas que aprendí sobre el cuidado de mi niño me las enseñaron las personas que me criaron				

56

Tengo en casa medicamentos necesarios para lo que requiere mi niño en caso se enferme.				
--	--	--	--	--

ANEXO B: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO

El nivel de confiabilidad por índice Alfa de Cronbach se estableció en 0,94 dividiendo la prueba en tres factores (Microsistema, Mesosistema y Macrosistema), abarcando diez dimensiones.

ANEXO: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO

Confiabilidad del Instrumento mediante el Alfa Cronbach

Estadísticas de fiabilidad

Alfa Cronbach	Alfa Cronbach basada en elementos estandarizados	N de elementos
0.94	0.94	22

ANEXO C. VALIDEZ A TRAVEZ DE JUICIO DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO

La prueba fue validada a través de juicio de 10 expertos con aplicación a una muestra de 164 madres primerizas en la ciudad de Trujillo, Perú, con edades entre 14 y 30 años.

ANEXO D. CONSENTIMIENTO INFORMADO

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES

El propósito de este protocolo es brindar a los y a las participantes en esta investigación, una explicación clara de la naturaleza de la misma, así como del rol que tienen en ella.

La meta de este estudio es realizar **una encuesta enfocada en la adopción maternal que tienen las madres primerizas a sus hijos menores de 1 año.**

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder a una entrevista a profundidad lo que le tomará 45 minutos de su tiempo. La conversación será grabada, así el investigador o investigadora podrá transcribir las ideas que usted haya expresado.

Su participación será voluntaria. La información que se recoja será estrictamente confidencial y no se podrá utilizar para ningún otro propósito que no esté contemplado en esta investigación.

En principio, las entrevistas serán totalmente confidencial, no se le pedirá identificación alguna.

Si tuviera alguna duda con relación al desarrollo de la investigación, usted es libre de formular las preguntas que considere pertinentes. Además, puede finalizar su participación en cualquier momento del estudio sin que esto represente algún perjuicio para usted. Si se sintiera incómoda o incómodo, frente a alguna de las preguntas, puede ponerlo en conocimiento de la persona a cargo de la investigación y abstenerse de responder.

Muchas gracias por su participación.

Yodoy mi consentimiento para participar en el estudio y soy consciente de que mi participación es enteramente voluntaria.

He recibido información en forma verbal sobre el estudio mencionado. He tenido la oportunidad de discutir sobre el estudio y hacer preguntas.

Al firmar este protocolo estoy de acuerdo con que mis datos personales, incluyendo datos relacionados a mi salud física y mental o condición, y raza u origen étnico, puedan ser usados según lo descrito en la hoja de información que detalla la investigación en la que estoy participando.

Entiendo que puedo finalizar mi participación en el estudio en cualquier momento, sin que esto represente algún perjuicio para mí.

Entiendo que recibiré una copia de este formulario de consentimiento e información del estudio y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo comunicarme con **con la investigadora.**

Dentro de los beneficios está la contribución al desarrollo de la investigación, la cual servirá de aporte científico a la mejora continua con resultados que podrán extenderse a ámbitos nacionales.

Nombre completo del participante

Firma

Fecha

Nombre del Investigador

Carla Carrasco Villarreal

Firma

Fecha

3/10/24